

DEPRESIÓN POSTPARTO

Cristina Forcelledo, Carmen Manso

INTRODUCCIÓN

La depresión postparto se entiende por la sintomatología depresiva mayor que se inicia en un período que no supera el año tras el día de dar a luz. Su frecuencia de presentación en un servicio de urgencias no es alta, pero su detección tiene gran importancia. No sólo por las implicaciones diagnósticas, terapéuticas y pronósticas, sino también por los factores relacionados con el abordaje tanto de la paciente afectada como del bebé y los apoyos familiares. Por tanto, cabe ser muy cuidadosos en su manejo.

La prevalencia del trastorno varía en porcentaje dependiendo del tipo de estudio y población, existiendo una consistencia de datos de entre 9 a 16% de la población general femenina.

Se estima que el debut de la clínica sucede en el período prenatal en aproximadamente un 50% de las pacientes. En la otra mitad, aquellas que comienzan a presentar síntomas en el postparto, el riesgo es notablemente mayor en los primeros 4-5 meses tras el nacimiento del bebé, disminuyendo en el período posterior.

La existencia de episodios previos de depresión mayor, ligados o no al embarazo o puerperio, duplican el riesgo de depresión postparto. Otros factores de riesgo frecuentemente asociados son los eventos estresores en el período del embarazo, y la escasez de apoyos sociales y económicos tras el parto. Existen otros muchos factores mencionados en la literatura como posiblemente relacionados con la presentación, pero con escasa consistencia (síntomas de ansiedad, neuroticismo elevado, multiparidad, embarazo no deseado, dificultades para la lactancia, patología somática concomitante, historia de abusos...).

Entre las posibles consecuencias del cuadro, se encuentra la claudicación o incomprensión del contexto de apoyo de la paciente, y la negligencia de cuidados del bebé, relacionándose con una mayor probabilidad de alteraciones en su desarrollo psíquico. Hay pocos estudios sobre tentativas autolíticas, suicidio consumado e infanticidio en el contexto de esta patología, pero los datos sugieren un riesgo menor al de la población afectada de un episodio depresivo mayor no relacionado con el puerperio.

El origen de la depresión postparto es desconocido. Se entiende que el mecanismo no difiere mucho de los comunes a la patología depresiva general, si bien pueden verse implicados los factores hormonales que conlleva el proceso evolutivo del embarazo y el parto, así como una susceptibilidad genética de base.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico en base a los manuales actuales de los que disponemos es poco concreto en esta entidad clínica. El DSM-5 añade un especificador al episodio depresivo mayor llamado “con debut en el periparto”, si bien solo permite su inclusión a aquellos síntomas que se inician dentro del mes posterior al parto, y los síntomas deben durar al menos 2 semanas. Esto no se corresponde con el consenso clínico universal sobre el trastorno, que fija hasta en un año dicho período.

La presentación de una depresión postparto en un servicio de urgencias suele seguir, efectivamente, las manifestaciones clínicas de un episodio depresivo mayor. La iniciativa de acudir para una exploración puede venir tanto de la paciente como de su contexto de apoyo,

dentro de una observación subjetiva o comportamientos anómalos, incluyendo un intento auto o heterolesivo. Por las implicaciones que conlleva, es muy importante hacer una evaluación detallada que detecte síntomas de posible riesgo. Dentro de la anamnesis, deberemos explorar:

- Antecedentes personales somáticos. Historia del embarazo actual y previos, si procede.
- Antecedentes personales y familiares de salud mental, especialmente afectivos y psicóticos. Historia de episodios de riesgo autolítico.
- Consumo de tóxicos: alcohol, tabaco y otros (cannabis, cocaína...).
- Contexto social, familiar y apoyos actuales.
- Estresores ambientales.
- Exploración psicopatológica propia de la clínica depresiva mayor:
- Facies triste, contacto retraído y distante, inquietud o inhibición psicomotriz, alteraciones en la comunicación (discurso parco, hipoprosodia, elevada latencia de respuestas).
- Hipotimia mantenida, labilidad emocional o alexitimia, apatía, anergia, anhedonia. Estos síntomas pueden centrarse en el bebé: desinterés y negligencia de sus cuidados, irritabilidad excesiva o escasa respuesta emocional hacia conductas propias del lactante.
- Desorden del ritmo instinto-vegetativo (hiporexia con o sin pérdida ponderal cuantificada, insomnio o hipersomnias).
- Dificultad para la concentración y la toma de decisiones.
- Cogniciones y rumiaciones centradas en la desesperanza, la melancolía, la ruina o la culpa.
- Alteraciones sensorio-perceptivas sugerentes de clínica psicótica activa.
- Cogniciones tanáticas y autolíticas/heterolíticas, distanciamiento y egosintonismo con las mismas, planificación de un acto suicida y acceso a medios.
- Conciencia de enfermedad y juicio de realidad.

El diagnóstico se hará en base a los criterios dispuestos para un episodio depresivo mayor según el DSM-5 requiriendo un mínimo de 3 de ellos. Si bien la exploración no difiere mucho con la propia de la clínica afectiva, es esencial hacer hincapié en los aspectos específicos del cuadro que nos ocupa. Es pertinente realizar la entrevista a solas, dejando al bebé con los acompañantes de la paciente, no sin antes observar la interacción que tiene con el infante. Podemos encontrarnos con que las pacientes se muestren reticentes a dar información, por la percepción social de que deberían ser felices en el momento biográfico en que se encuentran.

La detección de un posible riesgo auto o heterolesivo debe ser la primera prioridad del psiquiatra en urgencias. Se debe preguntar de forma explícita por cogniciones y emociones que lleven a esa dirección. Si bien los datos sugieren un menor riesgo de paso al acto en esta población, nunca se debe pasar por alto y es mandatorio hacer una evaluación exhaustiva. Asimismo, también es fundamental descartar la existencia de una historia de maltrato conyugal en curso. Para ello se debe hacer uso de toda la información recopilada, tanto en la entrevista, como de la paciente y sus familiares, para evaluar la severidad, permitiéndonos abordar el cuadro de la manera más pertinente.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con las siguientes entidades:

- “Baby blues”: síntomas depresivos atenuados, leves, que se presentan en los primeros días tras el parto y se resuelven antes de 2 semanas aproximadamente. Difiere en intensidad, duración y evolución con la depresión postparto, y no precisa tratamiento.
- Episodio depresivo de un trastorno bipolar: realizar una adecuada historia clínica puede ayudar a su distinción, detectando episodios de hipomanía o manía previos. La presencia de una afectividad mixta o una mayor tendencia a la irritabilidad e inquietud o agitación

psicomotriz debe hacernos sospecharla.

- Psicosis postparto: síntomas agudos nucleares de escisión yoica (actividad alucinatoria, interpretaciones delirantes...) que conllevan repercusión afectiva y conductual. Es fundamental distinguirla de la depresión postparto por la diferencia de manejo y el mayor riesgo asociado de paso al acto en contexto de pérdida del criterio de realidad.
- Otros cuadros psiquiátricos: no es infrecuente la comorbilidad con trastornos de ansiedad o rasgos desadaptativos de personalidad. Una buena evaluación nos orientará en la dirección más adecuada.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

En caso de que la sintomatología sea leve o moderada, y los acompañantes tengan adecuados recursos para hacer una supervisión estrecha de la paciente y el bebé, se optará por el alta a domicilio, vinculando con los servicios de salud mental que le correspondan. Debe informarse del tratamiento a seguir, los plazos esperados para ver efectos con el mismo, la posible interferencia con la lactancia de los fármacos y los síntomas de alarma por los que, en el caso que precisen, deban volver a consultar en urgencias.

La gravedad de la clínica percibida en urgencias puede llevar al ingreso en la unidad de agudos de psiquiatría de estas pacientes. Por lo general, una vez más, no son criterios unificados y siguen las directrices del episodio depresivo mayor:

- Síntomas afectivos graves, con empeoramiento rápido y progresivo, que no han respondido a tratamiento farmacológico (si tienen).
- Sospecha de riesgo autolítico o heterolítico.
- Pérdida del juicio de realidad.
- Apoyo familiar nulo o claudicado.

El ingreso puede ser voluntario o, en caso de sospechar clínica psicótica o riesgo para la paciente o el bebé, involuntario. Es importante explicar bien a la madre y su familia la situación de justificación médica por la que se opta por esta decisión. Asimismo, en el caso de presentarse una agitación psicomotriz en el servicio de urgencias, no reconducible desde lo verbal, se podrá realizar una contención mecánica bajo el protocolo hospitalario y en presencia del personal de seguridad.

En caso de no existir un apoyo familiar que pueda hacerse cargo del bebé, será necesario comunicar la situación a los servicios sociales para su cuidado mientras la madre permanezca hospitalizada. También habrá que alertar en caso de sospechar un maltrato intradomiliario. Hay que tranquilizar a la paciente sobre este aspecto y focalizar la atención en su recuperación.

Desde el punto de vista farmacológico, es recomendable iniciar alternativas terapéuticas que tengan una baja interferencia con la lactancia, con el fin de favorecer la vinculación madre-hijo. Se planteará como primera línea los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS), o bien duales (ISRSN), así como ansiolíticos de duración corta-media para cubrir el período de latencia de inicio de acción. Se muestra aquí una lista de fármacos para uso práctico en la depresión postparto, con baja o nula concentración en leche materna:

- ISRS: Escitalopram, Sertralina, Paroxetina.
- ISRSN: Venlafaxina, Desvenlafaxina, Duloxetina.
- Benzodiacepinas: Lorazepam.
- Otros: Trazodona para el insomnio.

ALERTA: LO QUE NO SE DEBE PASAR EN URGENCIAS SOBRE LA DEPRESIÓN POSTPARTO

- En la depresión postparto, la detección de un posible riesgo para la paciente o el bebé será la primera prioridad.
- Hay que cotejar la información de una entrevista exhaustiva con la aportada por el contexto de apoyo.
- Nos deben alarmar las ideas auto o heterolesivas, las cogniciones de rumiación, desesperanza, ruina y culpa, la negligencia o desinterés de cuidados en el niño y la presencia de sintomatología psicótica.
- Se cursará ingreso en planta cuando los síntomas sean graves y/o no exista un adecuado apoyo familiar. Se alertará a servicios sociales en caso de que el bebé no tenga este apoyo.
- El tratamiento será, preferiblemente, con fármacos que estén a baja concentración en leche materna, para favorecer el vínculo materno-filial.

BIBLIOGRAFÍA

- Guille C, Newman R, Fryml LD, Lifton CK. Management of postpartum depression. J Midwifery Womens Health. 2013 Nov-Dec;58(6):643-53.
- Cuomo I, Maina G, Neal SM, De Montis G et al. Using Sertraline in Postpartum and Breastfeeding: Balancing Risks and Benefits, Expert Opinion on Drug Safety, (2018).
- Meltzer-Brody S, Howard Louise M, Bergink V et al. Postpartum psychiatric disorders. Nature Reviews Disease Primers 4, Article number:18022 (2018). PMID: 29695824.
- Ukatu N, Clare CA, Brulja M. Postpartum Depression Screening Tools: A Review. Psychosomatics 2018 May – Jun;59(3):211-219.
- Molyneaux E, Telesia LA, Henshaw C, Broath E, Bradley E, Howard LM. Antidepressants for preventing postnatal depression. Cochrane Database Syst Rev 2018 Apr 18;4.
- Smith B, Dubovsky SL. Pharmacotherapy of mood disorders and psychosis in pre- and postnatal women. Expert Opin Pharmacother 2017 Nov;18(16):1703-1719.
- Ghaedrahmati M, Kazemil A, Kheirabadi G, Ebrahimi A, Bahrami M. Postpartum depression risk factors: A narrative review. J Educ Health Promot 2017 Aug 9;6:60.
- Latendresse G, Elmore C, Deneris A. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors as First-Line Antidepressant Therapy for Perinatal Depression. J Midwifery Womens Health 2017 May;62(3):317-328.
- Orsolini L, Valchera A, Vecchiotti R, Tomasetti C, Iasevoli F. Suicide during Perinatal Period: Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Correlates. Front Psychiatry 2016. Aug 12;7:138.
- Norhayati MN, Hazlina NH, Asrenee AR, Emilin WM. Magnitude and risk factors for postpartum symptoms: a literature review. J Affect Disord. 2015 Apr 1;175:34-52.
- O'Hara MW, Wisner KL. Perinatal mental illness; definition, description and aetiology. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014 Jan;28(1):3.12.
- Howard MM, Mehta ND, Powrie R. Peripartum depression: Early recognition improves outcome. Cleve Clin J Med. 2017 May;84(5):388-396.